

22191823330/335

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

SERGIO NOGUEIRA NETO JUNIORIDADE: 41 PESO: 96 ALTURA: 181 PROFISSÃO: *Empresário - Emp. Civil*SINTOMAS: *Causa / engasgo c/ frequência (7:30 - 17h)*
*(sentir na cama - falido). Boca seca*QUEIXAS: *Ronco*MEDICAMENTOS: *Omeprazol - Belicard 20mg. / K20 (120mg)*
*Luviz (Omega 3) + da visão.*MÉDICO: *D*MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ NEXERCÍCIO FÍSICO: *2X semana*HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: *S* ALMOÇO: *S* LANCHE: *S* JANTAR: *S (19h)*HORA QUE DORME: *22-23* HORA QUE ACORDA: *6:30*COCHILHO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N *só final semana.*FUMO: ☒ S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:TIPO DE RESPIRAÇÃO: *nasal* BANHEIRO/NOITE: *1X*CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: *P=18cm* CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:OVERLAP: *não* MALLAMPATI: *IV* IAH: SPO2:PATOLOGIAS ASSOCIADAS: *Do*CIRURGIAS: (☒) NASAL (☒) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (☒) RESPIRATÓRIA (☒) ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

31/07/25 Avaliação (Cur mini - 01/08 - 03/09)
CPAP auto - For Heru.

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA TIPO "SPLIT NIGHT"

Nome: SERGIO NOGUEIRA NETO JUNIOR

Sexo: Masculino

Data do Exame: 08-04-2025

Idade: 42 anos

Peso: 100 kg

Altura: 1,81 m

Médico Solicitante: DR. ANTONIO AUGUSTO NEVES DA NOBRAGA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 08/04/2025 22:07 e finalizado às 09/04/2025 05:44.

A latência para início do sono foi de **10,0 min** e a latência para o sono REM de **4,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 163,5 min, com eficiência do sono de **91,9 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **1,5 %** de estágio N1, **30,9 %** de estágio N2, **20,2 %** de estágio N3 e **47,4 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 4,5 min. Ocorreram 6 despertares, sendo o índice de **0,8 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 4, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 4 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **1,5 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 2,3 e o IDR durante o sono NREM foi de 0,7. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 1,5 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 1,5 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 94%, a média de 94% e a mínima de 91%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 0,5 (nº/h), sendo que em REM foi de 2,3 (nº/h) e em NREM foi de 0,7 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Saturação da oxi-hemoglobina normal (91%);
2. Latência para o início do sono normal (10,0 min) (VN= 5 a 30 min);
3. Latência para o início do sono REM diminuída (4,5 min) (VN= 70 a 120 min);
4. Eficiência do sono normal (91,9 %) (VN= $\geq 85\%$);
5. Índice de despertares normal (0,8 n^o/h) (VN= até 15 n^o/h);
6. Diminuição do percentual do estágio N1 (1,5 %) (VN= 2% a 5%);
7. Diminuição do percentual do estágio N2 (30,9 %) (VN= 45% a 55%);
8. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (20,2 %) (VN= 13% a 23%);
9. Aumento do percentual do estágio REM (47,4 %) (VN= 20% a 25%);
10. Ronco leve, intermitente verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

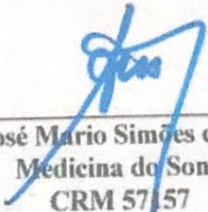
Exame polissonográfico Split-night, na segunda parte da noite para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5 cmH₂O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Dr. Victor Machado
+55 11 95141-6471

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame

Nome Sergio Nogueira Neto Junior
Início 13/11/2024 - 23:28:04

Nascimento 21/09/1983 (41 anos)
Tempo total 06:28:04 (388,1 min)

Sexo Masculino

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 13/11/2024

Peso 95 kg
Altura 1,80 m
IMC 29,3

Medicamentos

Respondido em 13/11/2024

☐ Nenhum
☒ Vitaminas de A a Z, vitam

Sintomas

Respondido em 13/11/2024

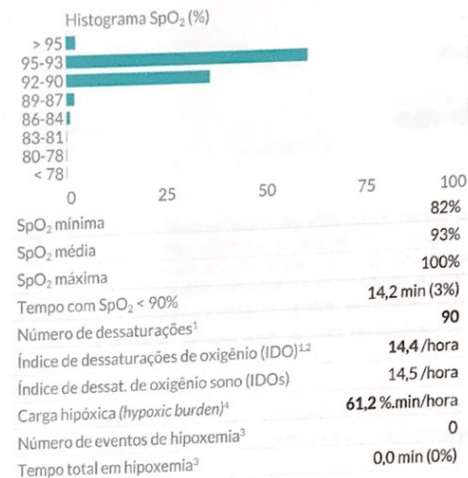
☐ Nenhum
☒ Ronco alto e frequente
☐ Sonolência excessiva diurna
☐ Sono não reparador
☒ Despertares frequentes
☐ Engasgos noturnos
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Cefaleia matinal
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas

Respondido em 13/11/2024

☐ Nenhuma
☐ Hipertensão arterial
☐ Diabetes
☐ Dislipidemia
☐ Câncer
☒ Depressão
☐ Arritmia cardíaca
☐ Infarto agudo do miocárdio
☐ Angina
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Bronquite / Enfisema
☐ Asma

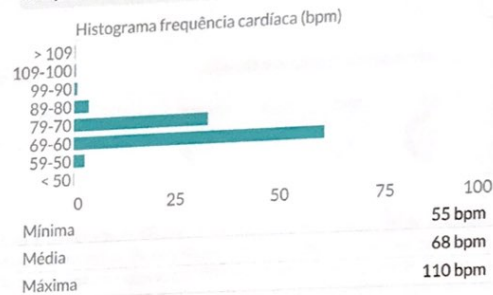
Oximetria (SpO₂)



Análise de ronco

Tempo de gravação 389,0 min
Tempo com ronco total 249,0 min (64%)
Tempo com ronco baixo 3,9 min (1%)
Tempo com ronco médio 42,8 min (11%)
Tempo com ronco alto 202,3 min (52%)

Frequência cardíaca



Fibrilação atrial (FA) estimada^{5,6,7}

Número de episódios 0
Tempo total em FA -
Episódio de menor duração -
Episódio de maior duração -
Duração média dos episódios -
Risco de FA Baixo

Sono estimado

Tempo total de sono 336,5 min
Tempo para dormir 13,0 min
Tempo acordado pós-sono 36,5 min
Eficiência do sono 87%

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).
5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.
6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.
7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.

Dr. Victor Machado
R11 95141-6471

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Biologix

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome Sergio Nogueira Neto Junior
Início 13/11/2024 - 23:28:04
Fim 14/11/2024 - 05:56:08

Nascimento 21/09/1983 (41 anos)
Tempo total 06:28:04 (388,1 min)
Tempo válido 06:16:12 (376,2 min)

Sexo Masculino

Condições na noite do exame

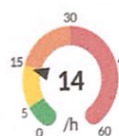
- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Resultado

Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2}



Valores de referência
IDO < 5 Normal
5 ≤ IDO < 15 Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30 Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30 Apneia do sono acentuada

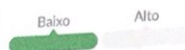
Tempo com SpO₂ < 90%



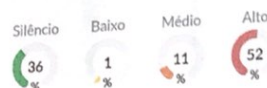
Carga hipóxica⁴ - Risco cardiovascular



Risco de FA^{5,6,7}



Intensidade do ronco registrado



Exame de polissonografia realizado no dia 13/11/2024, iniciado às 23:28 e terminado às 05:56. O tempo total de registro foi de 6h28min (388 minutos) e o tempo válido foi de 6h16min (376 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 90 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 14,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e permaneceu abaixo de 90% durante 3% do tempo de registro (14 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 64% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono leve (IDO 14,4/hora), nas condições descritas.
Foram detectados eventos de ronco durante 64% do tempo de registro.

Dr. Pedro Rodrigues Azeite
CRM 87176-SP / RQE 48835-1